Paliatívna starostlivosť v rutinnej nefrológii: nástroje s nízkym prahom pre krehkých a starších pacientov

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Paliatívna starostlivosť tu nie je poslednou zastávkou, ale nízkym prahom – vstúpiť sa dá skôr a bez veľkého rozhodnutia.

Pacientov, ktorí sa do konečného štádia obličkového ochorenia dostávajú vo vysokom veku a s výraznou krehkosťou, pribúda. Prehľad v Nephrology Dialysis Transplantation upozorňuje, že paliatívne zásady síce odporúčania uznávajú, no ich praktické zavedenie zostáva nedostatočné – a že nefrológ nepotrebuje na ich používanie špecializovaný výcvik.

Nefrológia sa dlho definovala schopnosťou nahradiť zlyhávajúcu funkciu. Táto schopnosť je mimoriadna, no prináša so sebou aj tichý predpoklad: že ak náhrada existuje, má sa použiť. U staršieho a krehkého pacienta už automaticky neplatí.

Autorský kolektív pod vedením Judith Böhmovej a Balazsa Odlera formuluje východisko jasne: integrácia paliatívnych zásad do klinickej praxe sa stala **naliehavou potrebou** pre rastúci počet pacientov vo vysokom veku a s krehkosťou, ktorí dosahujú konečné štádium ochorenia obličiek. A hoci odporúčania tieto zásady podporujú, **ich praktické zavedenie zostáva nedostatočné**.

Šesť oblastí, ktoré prehľad pokrýva

Prehľad postupuje cez šesť domén, ktoré spolu tvoria priebeh starostlivosti, nie samostatné epizódy:

1. prognostika,
2. rozhovory o cieľoch starostlivosti,
3. hodnotenie konzervatívneho nefrologického postupu,
4. individualizované nastavenie dialýzy,
5. depreskripcia liekov,
6. ukončenie dialýzy.

Záver autorov znie, že nefrológovia môžu do svojej praxe zaradiť **nástroje s nízkym prahom aj bez špecializovaného paliatívneho výcviku**, a tým obmedziť zbytočné intervencie a zlepšiť manažment symptómov.

Prognostika: nevyhnutná, hoci nepresná

Rozhovor o cieľoch starostlivosti bez odhadu prognózy je prázdny – pacient nemá podľa čoho voliť. Nefrológovia sa však odhadom vyhýbajú, čiastočne preto, že sú neisté.

Najjednoduchším nástrojom zostáva **prekvapujúca otázka**: „Prekvapilo by ma, keby tento pacient zomrel v priebehu najbližších dvanástich mesiacov?“ Odpoveď „nie“ nie je prognózou – je spúšťačom. Znamená, že je čas hovoriť o cieľoch, doriešiť plánovanie starostlivosti vopred a zvážiť, ktoré intervencie ešte dávajú zmysel.

Presnosť tejto otázky je len stredná a jej výsledok sa nemá pacientovi tlmočiť ako predpoveď. Jej hodnota spočíva v tom, že rozhovor otvorí – a to je viac, než dosiahne dokonalý prognostický model, ktorý sa nepoužije.

Konzervatívny postup nie je rezignácia

Najčastejším nedorozumením je predstava, že konzervatívny nefrologický postup znamená „nerobiť nič“. Ide pritom o aktívne vedenú starostlivosť: manažment symptómov, korekcia anémie a acidózy, kontrola objemu, liečba svrbenia a bolesti, psychosociálna a duchovná podpora, plánovanie záveru života.

Dôkazy sú konkrétnejšie, než sa vo všeobecnosti predpokladá. Holandská kohorta Woutera Verberneho a spolupracovníkov porovnala 107 konzervatívne vedených pacientov s 204 pacientmi na náhrade funkcie obličiek vo veku 70 rokov a viac:

- V celom súbore bol medián prežívania 3,1 roka pri náhrade funkcie oproti 1,5 roka pri konzervatívnom postupe.
- **Vo veku 80 rokov a viac sa rozdiel prestal potvrdzovať** – 2,1 oproti 1,4 roka ($p = 0,08$).
- Pri vysokej komorbidite (Daviesovo skóre 3 a viac) bol rozdiel síce významný, ale malý – 1,8 oproti 1,0 roka.

Staršia britská práca Rachel Carsonovej a spolupracovníkov našla u pacientov nad 70 rokov výraznejší rozdiel v prežívaní (medián 37,8 oproti 13,9 mesiaca), zároveň však ukázala niečo podstatnejšie: konzervatívne vedení pacienti mali **podobný počet dní strávených mimo nemocnice** a významne vyššiu pravdepodobnosť, že zomrú doma alebo v hospici (pomer šancí 4,15).

Voľba teda spravidla nie je medzi životom a smrťou, ale medzi **dlhším časom stráveným čiastočne v nemocnici a kratším časom stráveným prevažne doma**. Takto formulovaná otázka je pre pacienta zodpovedateľná – na rozdiel od otázky, či „chce dialýzu“.

Individualizované nastavenie dialýzy

Rozhodnutie nie je binárne. Aj u pacienta, ktorý dialýzu začne, možno paliatívny prístup uplatniť:

- **Inkrementálny začiatok** – dve procedúry týždenne pri zachovanej reziduálnej funkcii namiesto automatických troch.
- **Predpis vedený symptómami**, nie cieľovým Kt/V, tam, kde cieľom už nie je maximalizovať prežívanie.
- **Realistické plánovanie cievneho prístupu.** U pacienta s krátkou očakávanou prognózou môže byť centrálny katéter primeranejšou voľbou než opakované pokusy o fistulu s hojením trvajúcim mesiace. Ide o jeden z mála prípadov, keď je „horší“ prístup správnym rozhodnutím.
- **Vopred dohodnutá skúšobná doba.** Časovo ohraničený pokus s vopred stanovenými kritériami hodnotenia mení ukončenie dialýzy z porážky na naplánovaný krok.

Depreskripcia

Pacient s pokročilým ochorením obličiek užíva bežne desať a viac liekov. Časť z nich má prínos, ktorý sa dostaví o roky – a teda mimo očakávaného horizontu. Systematicky prehodnotiť treba najmä:

- **statíny**, ktorých prínos v primárnej prevencii sa prejaví po rokoch;

- **viazače fosfátov**, ktoré predstavujú veľkú tabletovú záťaž pri cieli, ktorý už nie je aktuálny;
- **cieľové hodnoty hemoglobínu** – pri paliatívnom cieli je rozhodujúca únava, nie čísla;
- **antihypertenzíva**, ktoré v terminálnej fáze zvyšujú riziko pádov a ortostatickej hypotenzie;
- **diétne obmedzenia**, ktoré v tejto fáze zhoršujú kvalitu života bez zodpovedajúceho prínosu.

Depreskripcia nie je jednorazovým „odľahčením“, ale súčasťou pravidelnej revízie. Súvisí to aj s polyfarmáciou, ktorá je pri chronickej chorobe obličiek samostatným rizikovým faktorom.

Ukončenie dialýzy

Ukončenie dialýzy je v krajinách s vysokým príjmom častou cestou k úmrtiu – podľa registrových údajov ide rádovo o pätinu úmrtí dialyzovaných pacientov. Napriek tomu sa naň pripravuje len zriedka.

Po ukončení nasleduje spravidla **niekoľko dní** (v publikovaných súboroch medián približne štyri až osem dní podľa modality). Na tento krátky čas treba mať plán, nie improvizovať. Plán má obsahovať:

- lieky na bolesť, dýchavičnosť, úzkosť, nauzeu a dýchacie sekréty **predpísané vopred**, vrátane podania mimo perorálnej cesty;
- jasné určenie miesta starostlivosti – domov, hospic alebo lôžkové oddelenie – a zabezpečenie dostupnosti liekov na danom mieste;
- zrozumiteľné vysvetlenie priebehu rodine, vrátane toho, že narastajúca spavosť je očakávaným javom;
- dohodu, čo sa stane pri zhoršení, aby výsledkom nebolo neplánované volanie záchrannej služby.

Ukončenie dialýzy nie je ukončením starostlivosti. Rozdiel medzi dobrým a zlým priebehom týchto dní spočíva takmer výlučne v tom, či bol plán pripravený vopred.

Limity

- Ide o **naratívny prehľad**, nie o systematickú syntézu – sila dôkazov za jednotlivými tvrdeniami sa líši a výber literatúry nie je vopred definovaný.
- Prehľad opisuje **rakúsky a stredoeurópsky kontext**; dostupnosť hospicovej a domácej paliatívnej starostlivosti sa medzi krajinami výrazne líši a od nej závisí realizovateľnosť viacerých odporúčaní.
- Údaje o konzervatívnom postupe pochádzajú z **observačných štúdií** s malými súbormi a s výrazným výberovým skreslením – pacienti volia konzervatívny postup preto, že sú chorší, a randomizovaná štúdia v tejto oblasti je len ťažko uskutočniteľná.

Záver

Prehľad neponúka nový nástroj, ale odstraňuje jednu prekážku: presvedčenie, že paliatívna starostlivosť je samostatná odbornosť, ktorá sa má odovzdať niekomu inému. Prognostika, rozhovor o cieľoch, depreskripcia a plánovanie záveru života sú nástrojmi s nízkym prahom, ktoré nefrológ používať vie – a spravidla je na ne v lepšom postavení než ktokoľvek iný, pretože pacienta pozná roky.

Paliatívny prístup pritom nie je alternatívou k aktívnej nefrologickej liečbe. Je spôsobom, ako rozhodovať o dialýze, o liekoch aj o prípadnom ukončení liečby tak, aby to zodpovedalo tomu, čo je pre konkrétneho pacienta dôležité. U krehkého osemdesiatnika to znamená položiť otázku skôr a inak – nie „začneme dialýzu?“, ale „čo chcete, aby sme týmto časom získali?“.

Súvisiace články

- Keď pacient nechce hovoriť o svojich hodnotách – skrytá prekážka spoločného rozhodovania.
- Krehkosť pri CKD – výživa, pohyb a funkčné hodnotenie.
- CKD ako samostatný faktor polyfarmácie.
- Predialyzačná edukácia a voľba modality.

Zdroje

1. **Judith Böhm, Martin Windpessl, Matthias Huemer, Eva K. Masel, Marcus Säemann, Andreas Kronbichler, Balazs Odler.** *Integrating palliative care into routine nephrology practice.* Nephrology Dialysis Transplantation. 2026 Aug 3 (online ahead of print). doi: 10.1093/ndt/gfag170. PubMed; DOI.
2. **Wouter R. Verberne, A. B. M. Tom Geers, Wilbert T. Jellema, Hieronymus H. Vincent, Johannes J. M. van Delden, Willem Jan W. Bos.** *Comparative Survival among Older Adults with Advanced Kidney Disease Managed Conservatively Versus with Dialysis.* Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2016;11(4):633–640. doi: 10.2215/CJN.07510715. PubMed.
3. **Rachel C. Carson, Maciej Juszczak, Andrew Davenport, Aine Burns.** *Is maximum conservative management an equivalent treatment option to dialysis for elderly patients with significant comorbid disease?* Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2009;4(10):1611–1619. doi: 10.2215/CJN.00510109. PubMed.

Poznámka k dôkazom: *Bibliografické údaje, kompletné autorstvo aj obsah prehľadu – naliehavosť integrácie paliatívnych zásad, nedostatočné praktické zavedenie napriek podpore v odporúčaniach, všetkých šesť pokrytých oblastí a záver o použiteľnosti nástrojov s nízkym prahom bez špecializovaného výcviku – boli overené v zázname PubMed a Europe PMC. Plný text prehľadu je za platobnou bariérou vydavateľa a nebol sprístupnený; konkrétne algoritmy ani odporúčacie body z plnej verzie tu preto nie sú citované. Číselné údaje o prežívaní pri konzervatívnom postupe (3,1 oproti 1,5 roka; 2,1 oproti 1,4 roka pri veku ≥ 80 rokov; 1,8 oproti 1,0 roka pri Daviesovom skóre ≥ 3; 37,8 oproti 13,9 mesiaca; pomer šancí 4,15 pre úmrtie doma alebo v hospici) pochádzajú z dvoch samostatne overených štúdií a v prehľade sa v tejto podobe neuvádzajú. Prekvapujúca otázka, praktické postupy pri individualizácii dialýzy, zoznam liekov na depreskripciu, plán pri ukončení dialýzy a údaje o podiele ukončenia dialýzy na úmrtiach a o dĺžke prežívania po ňom sú* ***vlastným odborným spracovaním*** *opretým o etablované poznatky.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=paliativna-starostlivost-nefrologia-krehki-starsi-eskd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.